

TEMA 3.12 • UROLOGÍA

Patología Escrotal Crónica

PERFIL EUNACOM 1.03.12

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La patología escrotal crónica agrupa un conjunto de condiciones de evolución lenta que, a diferencia del **Escroto Agudo**, no suelen representar una emergencia quirúrgica inmediata, pero impactan significativamente en la calidad de vida, la fertilidad y la salud psicológica del paciente. Los pilares del diagnóstico son el **examen físico** minucioso y la **ecografía doppler testicular**.

Hidrocele

El **hidrocele** se define como la acumulación anormal de líquido seroso entre las capas parietal y visceral de la túnica vaginal. Es la causa más común de aumento de volumen escrotal indoloro.

Fisiopatología

La etiología difiere marcadamente según la edad del paciente:

En Niños: Generalmente es un **hidrocele comunicante**. Se produce por la persistencia del **conducto peritoneo-vaginal**, lo que permite el paso de líquido peritoneal hacia el escroto. Es fisiológico en recién nacidos y suele resolverse espontáneamente antes de los 2 años. **En Adultos:** Suele ser **idiopático** (no comunicante). Se produce por un desequilibrio entre la secreción y la reabsorción de líquido por la túnica vaginal. También puede ser secundario a procesos inflamatorios (**Epididimitis**), traumatismos o tumores.

NOTA CLÍNICA

En el hidrocele comunicante (niños), el volumen escrotal puede variar durante el día, aumentando con el llanto o la actividad (maniobras de Valsalva) y disminuyendo durante el sueño.

Cuadro Clínico y Diagnóstico

Aumento de volumen: Es homogéneo, liso y habitualmente indoloro. El testículo puede ser difícil de palpar si el hidrocele es a tensión. **Prueba de Transiluminación:** Es el signo clínico patognomónico. Al aplicar una fuente de luz directa sobre el escroto, esta atraviesa el líquido seroso, otorgando un brillo anaranjado/rojizo. **Ecografía:** Se solicita ante la duda diagnóstica o si el testículo no es palpable, para descartar masas subyacentes. Se observa una colección anecoica (negra) que rodea al testículo.

Manejo

1. **Observación:** Es la conducta inicial en la mayoría de los casos, especialmente si es asintomático. 2. **Cirugía:** Indicada si hay dolor crónico, si es un hidrocele gigante que causa molestia estética/psicológica, o si es comunicante y persiste más allá de los 2 años. En niños: Ligadura del conducto peritoneo-vaginal (abordaje inguinal). En adultos: Resección o eversión de la túnica vaginal (abordaje escrotal).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca puncionar ni drenar un hidrocele en la consulta. El líquido se reproduce rápidamente y existe un alto riesgo de infección (piócele) o hemorragia (hematocele).

Varicocele

El **varicocele** consiste en la dilatación varicosa de las venas del **plexo pampiniforme** que drenan el testículo. Es más frecuente en el lado izquierdo (90%) debido a la desembocadura en ángulo recto de la vena espermática izquierda en la vena renal.

Clínica

Se presenta como una masa peritesticular, generalmente indolora o descrita como una "pesadez" escrotal que aumenta tras bipedestación prolongada o ejercicio. Al examen físico, se palpa

como una **"bolsa de gusanos"** por encima del testículo.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El varicocele suele ser **reducible** en decúbito supino. Si un varicocele es derecho, no desaparece al acostarse o es de inicio súbito en un adulto, se debe sospechar una masa retroperitoneal o una **trombosis de la vena renal** que obstruya el drenaje venoso.

Indicaciones de Cirugía (Varicocelectomía)

No todos los varicoceles se operan. Las indicaciones precisas son:

1. **Dolor testicular crónico:** Que no cede a manejo conservador. 2. **Infertilidad:** Comprobada mediante un **espermograma alterado** (oligozoospermia, astenozoospermia) en un paciente que busca concepción. 3. **Atrofia Testicular:** Especialmente relevante en adolescentes, donde se observa una diferencia de volumen >20% o >2cc entre ambos testículos.

Quistes Intra-escrotales

Incluyen diversas lesiones quísticas benignas que se palpan como nódulos independientes del testículo.

Quiste del Epidídimo: Colección de líquido seroso en el epidídimo.

Espermatocele: Quiste que contiene espermatozoides, habitualmente localizado en la cabeza del epidídimo. **Quiste de la Hidátide de Morgagni:** Remanente embriológico que puede quistificarse.

Diagnóstico y Manejo

La mayoría son **asintomáticos** y se descubren por autoexamen. El diagnóstico se confirma con **ecografía testicular** para diferenciar estas lesiones quísticas de un tumor sólido. **Tratamiento:** Observación. Solo se operan si son gigantes o causan dolor significativo.

EUNACOM CRITERIOS

Ante cualquier masa escrotal **sólida** que no transilumina, se debe sospechar **Cáncer de Testículo** hasta que se demuestre lo contrario. La ecografía es fundamental para esta distinción.

Dolor Testicular Crónico (Orquialgia Crónica)

Se define como el dolor intermitente o constante, unilateral o bilateral, de más de 3 meses de evolución que interfiere con las actividades diarias.

Enfoque Diagnóstico

1. **Historia Clínica:** Evaluar antecedentes de infecciones, cirugías previas (vasectomía, herniorrafia) y características del dolor. 2. **Examen Físico:** Buscar dirigidamente varicocele, quistes o puntos gatillo. 3. **Ecografía:** Si el examen físico es anormal, la eco ayuda a identificar la causa tratable.

Manejo de la Orquialgia Inespecífica

Si el examen físico y la ecografía son **normales**, se diagnostica orquialgia crónica inespecífica. El manejo es escalonado: **Primera línea:** Analgésicos (Paracetamol, AINEs), uso de **suspensorio escrotal** (calzoncillos ajustados) y evitar actividades desencadenantes. **Segunda línea:** Moduladores del dolor (antidepresivos tricíclicos como amitriptilina o anticonvulsivantes como gabapentina) y psicoterapia. **Tercera línea:** Bloqueos del

cordón espermático o denervación microquirúrgica (casos seleccionados).

Tabla Comparativa de Patología Escrotal Crónica

TABLA 3.12.1: PATOLOGÍA VS HALLAZGO CLAVE AL EXAMEN FÍSICO				
PATOLOGÍA	HALLAZGO CLAVE AL EXAMEN FÍSICO	TRANSILUMINACIÓN	DIAGNÓSTICO	MANEJO INICIAL
Hidrocele	Aumento de volumen liso, homogéneo	Positiva (+)	Clínico	Observación
Varicocele	Masa en "bolsa de gusanos", reducible	Negativa (-)	Clínico / Eco Doppler	Observación / Cirugía (si hay atrofia/dolor/infertilidad)
Quiste Epidídimo	Nódulo pequeño, firme, separado del testículo	Negativa (-)	Ecografía	Tranquilizar al paciente
Cáncer Testicular	Masa pétrea, sólida, fija al testículo	Negativa (-)	Eco + Marcadores	Orquiectomía radical
Orquialgia Inespecífica	Examen físico normal, testículo sensible	Negativa (-)	Clínico (descarte)	AINEs + Suspensión

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de treinta años consulta por aumento de volumen escrotal izquierdo de varios meses de evolución, indoloro. Al examen físico se palpa un aumento de volumen homogéneo y la prueba de transiluminación es positiva; se ilumina anaranjado al pasar la linterna. El testículo se palpa normal dentro del escroto. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Patología Escrotal Crónica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El hidrocele produce aumento de volumen escrotal homogéneo con prueba de transiluminación positiva, que es el único hallazgo escrotal con esta característica; el tratamiento es observación salvo dolor crónico o gran tamaño
- El varicocele se palpa como bolsa de gusanos, es reductible, y la transiluminación es negativa; se observa si es asintomático y se opera si hay dolor crónico, infertilidad o atrofia testicular
- Un varicocele de inicio agudo en el lado izquierdo debe hacer sospechar trombosis de la vena renal izquierda como causa secundaria
- Las tres indicaciones de cirugía del varicocele son: dolor crónico, infertilidad demostrada clínicamente o por espermograma, y atrofia testicular
- Los quistes intraescrotales como el espermatocoele y los quistes del epidídimo se ven quísticos en la ecografía, a diferencia del cáncer testicular que se ve sólido; el tratamiento es observación salvo dolor crónico
- El dolor testicular crónico se estudia con examen físico; si hay alteración se pide ecografía; si el examen físico es normal no está indicada la ecografía de rutina
- La orquialgia crónica inespecífica se maneja con analgésicos, AINEs, suspensión escrotal, y en casos refractarios psicoterapia y moduladores del dolor como antidepresivos

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Si un paciente consulta por infertilidad y al examen físico palpas venas dilatadas en el escroto, el diagnóstico es **Varicocele** y la conducta es solicitar un **espermograma**. Si este sale alterado, la indicación es **quirúrgica**.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PATOLOGÍA ESCROTAL CRÓNICA)

PREGUNTA 1

Paciente de treinta años consulta por aumento de volumen escrotal izquierdo de varios meses de evolución, indoloro. Al examen físico se palpa un aumento de volumen homogéneo y la prueba de transiluminación es positiva; se ilumina anaranjado al pasar la linterna. El testículo se palpa normal dentro del escroto. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

- A) Varicocele izquierdo; derivar a cirugía porque puede causar infertilidad
- B) Hidrocele; observación porque en adultos la conducta es expectante salvo complicaciones
- C) Tumor testicular; ecografía urgente para confirmar y derivar a urología
- D) Quiste del epidídimo; ecografía para confirmar y cirugía de resección
- E) Hidrocele comunicante; cirugía inmediata para ligar el conducto peritoneovaginal

PREGUNTA 2

Adolescente de dieciséis años con varicocele izquierdo confirmado, asintomático, sin dolor. Se realiza espermograma preventivo que muestra oligospermia moderada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Solo observar porque el varicocele asintomático nunca requiere tratamiento en menores de edad
- B) Ligadura del plexo pampiniforme porque el espermograma alterado es indicación de cirugía
- C) Iniciar tratamiento con tamsulosina para mejorar el flujo escrotal
- D) Ecografía testicular bilateral para confirmar atrofia testicular antes de operar
- E) Derivar a fertilidad solo cuando el paciente desee tener hijos en el futuro

PREGUNTA 3

Paciente de cuarenta años con dolor testicular derecho crónico de seis meses de evolución. El examen físico testicular es completamente normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Solicitar ecografía testicular bilateral de rutina para descartar causas estructurales
- B) Manejo con analgésicos, AINEs y suspensión escrotal; si no responde, considerar psicoterapia
- C) Biopsia testicular para descartar cáncer como causa del dolor crónico
- D) Derivar inmediatamente a urología para exploración quirúrgica diagnóstica
- E) Iniciar antibioterapia empírica por cuatro semanas asumiendo epididimitis crónica

RESUMEN: PATOLOGÍA ESCROTAL CRÓNICA

La patología escrotal crónica incluye varias condiciones de manejo diferente: hidrocele, varicocele, quistes intraescrotales y dolor testicular crónico inespecífico. El hidrocele es la acumulación de líquido en el escroto. En niños es por persistencia del conducto peritoneovaginal y se resuelve espontáneamente en los primeros años de vida. En adultos es idiopático. Clínicamente produce aumento de volumen escrotal homogéneo sin alteración del testículo, con prueba de transiluminación positiva que es patognomónica: la luz atraviesa el líquido y se ve anaranjado del otro lado del escroto. El tratamiento en la mayoría de los casos es solo observación; la cirugía se indica si hay dolor crónico o si es muy grande con impacto estético o psicológico. El varicocele son varices del plexo pampiniforme alrededor del testículo. Se palpa como bolsa de gusanos, es reductible en muchos casos, y la transiluminación es negativa porque es vascular no líquida. La mayoría son benignos y se observan. Las indicaciones de cirugía son: dolor crónico, infertilidad demostrada clínicamente o por espermograma, y atrofia testicular. Un varicocele de inicio agudo en el lado izquierdo puede indicar trombosis de la vena renal izquierda ya que el varicocele izquierdo drena hacia esa vena. Los quistes intraescrotales como quistes del epidídimo, espermatocele y quistes testiculares son habitualmente asintomáticos y se ven como masas quísticas en la ecografía, a diferencia del cáncer que es sólido. El tratamiento es observación salvo dolor crónico o gran tamaño. El dolor testicular crónico inespecífico se maneja con examen físico completo y ecografía testicular si hay alteración en el examen. Si todo está normal, se asume orquialgia crónica inespecífica y el tratamiento son analgésicos, AINEs, suspensión escrotal, y en casos refractarios psicoterapia y moduladores del dolor como antidepresivos. La ecografía no está indicada si el examen físico es completamente normal.